

פרוטוקול ניהול כילותרקס

יחידה לטיפול נמרץ ילדים (PICU) | 2025

עודכן לפי פרוטוקול מחלקתי

1. קריטריונים לאבחנה

- **TG:** $> 110 \text{ mg/dL}$ (או $< 80\%$ מרמתם בדם).
- **תאים:** $< 1,000$ ($< 80\%$ לימפוציטים).
- **Gold Standard:** כילומיקרוניום.
- * נודל יכול להיות צלול בצום/פוסט-אופ.

2. סיווג (Classification)

High Volume
 $< 20 \text{ מ"ל/ק"ג/יום}$
(או $< 10 \text{ ביום ה-5}$)**Low Volume**
 $> 20 \text{ מ"ל/ק"ג/יום}$

3. דימות (Imaging)

- **בסיסי:** CXR, US, חזה, אקו לב.
- **שלילת חסימה:** דופלר ורידים, MRV, צנחור.
- **מתקדם:** DCMRL (Dynamic Contrast MR), מיפוי T2.

4. ניהול נוזלים והחזרים (Fluid Replacement)

יעד החזר: 50% - 75% מהאיבודים

דוגמה לחישוב (בלוק 4 שעות):

1. מדידה: סך יציאה (07:00-11:00) = 40 מ"ל .
2. חישוב יעד (50%): $40 \times 0.5 = 20 \text{ מ"ל להחזר}$.
3. קצב לשעה: $20 \text{ מ"ל} / 4 \text{ שעות} = 5 \text{ מ"ל/שעה}$ (ב-4 שעות הבאות).

5. אלגוריתם טיפולי (Management Strategy)

קו ראשון: Low Volume

1. דיאטה: דלת LCT למשך 72 שעות.
2. המשך: מעבר לכלכלת MCT (Monogen/Enfaport).
3. משך הדיאטה: 4 שבועות (Post Op), 6 שבועות (אחר).
4. הוצאת נקד: חפוקה $> 2 \text{ מ"ל/ק"ג/יום}$.

קו ראשון: High Volume

1. צום (NPO) + TPN מלא למשך 7 ימים.
2. התחלת Octreotide מיידי.
2. טיפול משותף להורדת CVP.

כישלון טיפול (יום 6-7)?

- DCMRL (תדמיה).
- TDE / Ligation.
- Pleurodesis: (Betadine/Doxycycline).
- LVA / Shunt.

6. פרוטוקול אוקטראטיד (Octreotide Protocol)

מינונים וטיטרציה

התחלה: $1.0 - 0.5 \text{ mcg/kg/hr}$.

העלאה: כ- 1 mcg/kg/hr כל 24 שעות (או מהר יותר לפי שיקול קליני).

מקסי' מינון: 10 mcg/kg/hr .

תגובה וגמילה (Weaning)

תגובה לטיפול: ירידה בנפח ל-Low Volume או $> 10 \text{ מ"ל/ק"ג}$.

מתי לגמול? רק לאחר רזולוציה/התייצבות.

קצב גמילה: הורדה של 25% מהמינון כל 24 שעות.

ניטור תופעות לוואי

- גלוקוז (היפרגליקמיה).
- תפקודי תריס (TFT) - בשימוש ממושך.
- תפקודי כבד, QTc ב-אק"ג.
- סימני NEC / אי-סבילות לאוכל.

7. תוספים וניטור (Supplements & Labs)

תוספים (לאיבוד ממושך):

- Carnitine
- ויטמינים: A, D, E, K (שבועי)
- מולטיטרינט, Trace Elements (אבץ, נחושת).

מעבדה:

- ימי: אלקטרוליטים, אלבומין, ספירה.
- קרישה: Fibrinogen, ATIII (פעמיים בשבוע).

איבוד חיסוני

- ביינוץ אימונולוגי ומחלות זיהומיות
- לימפונדיה: שקול רספרם (PCP).
- היפוגמגלובוליןמיה: שקול מוקטיסין / IVIG.

8. טיפול ממוקד בגנטי

- **Sirolimus (mTORi):** להפרעות לימפוציטיות/CCLA.
- **Trametinib (MEKi):** למוטציות ספציפיות.

9. ניהול כשל חדר ימין (RV Failure)

Sildenafil: $0.5 - 2 \text{ mg/kg}$ iNO: $10 - 20 \text{ ppm}$

Preload: שיתון.

Afterload: iNO, המנוע מ-PEEP.

Contractility: Milrinone.

כלי עזר לצוות רפואי - PICU 2025